World Health Organization

human reproduction programme hrp
research for impact
UNDP · UNFPA · UNICEF · WHO · WORLD BANK



Recomendações da OMS sobre cuidados maternos e neonatais para uma experiência pós-natal positiva

Sumário executivo

Introdução

O período pós-natal, definido aqui como o período que começa imediatamente após o nascimento do bebê e se estende até seis semanas (42 dias), é um momento crítico para mulheres, recém-nascidos, parceria, pais, cuidadores e familiares. Ainda assim, durante este período, as taxas de mortalidade e morbidade materna e neonatal permanecem inaceitavelmente altas, e as oportunidades para aumentar o bem-estar materno e apoiar os cuidados com o recém-nascido não foram totalmente utilizadas. Os serviços de cuidado pós-natal são um componente fundamental da continuidade dos cuidados maternos, neonatais e infantis, e a chave para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) sobre saúde reprodutiva, materna e infantil, incluindo metas para reduzir as taxas de mortalidade materna e acabar com as mortes evitáveis de recém-nascidos.

Alinhado aos ODS e à *Estratégia Global para a saúde de mulheres, das crianças e dos adolescentes*, e de acordo com uma abordagem baseada nos direitos humanos, os esforços de cuidado pós-natal devem se expandir além da cobertura e sobrevivência e incluir a qualidade do atendimento. Esta diretriz visa melhorar a qualidade dos cuidados pós-natais essenciais e de rotina para mulheres e recém-nascidos, com o objetivo final de melhorar a saúde e o bem-estar materno e neonatal. Ele reconhece "experiência pós-natal positiva" como um desfecho significativo para todas as mulheres que dão à luz e recém-nascidos, estabelecendo a base para a melhoria da saúde e do bem-estar no curto e longo prazo. Uma experiência pós-natal positiva é definida como aquela em que mulheres, recém-nascidos, parcerias, pais, cuidadores e famílias recebem informações, garantias e apoio de uma maneira consistente de profissionais de saúde motivados; em que um sistema de saúde flexível e com recursos reconheça as necessidades de mulheres e bebês e respeite seu contexto cultural.

Esta é uma diretriz consolidada de recomendações novas e existentes sobre cuidados pós-natais de rotina para mulheres e recém-nascidos que recebem cuidados pós-natais baseados na comunidade ou em qualquer cenário de recursos. Ela fornece um conjunto abrangente de recomendações para cuidados durante o período pós-natal, focado no pacote essencial que todas as mulheres e recém-nascidos devem receber, com a devida atenção à qualidade do atendimento; ou seja, a prestação e experiência de cuidados. Esta diretriz atualiza e expande as *WHO recommendations on postnatal care of the mother and newborn* (recomendações sobre cuidados pós-natal da mãe e do recém-nascido da OMS) de 2014 e complementa as diretrizes existentes da OMS sobre o manejo de complicações após o nascimento.

Público-alvo

As recomendações nesta diretriz têm a intenção de informar o desenvolvimento de políticas de saúde nacionais e subnacionais relevantes, protocolos clínicos e guias programáticos. Portanto, o público-alvo inclui formuladores de políticas de saúde pública nacionais e subnacionais, implementadores e gestores de programas de saúde materna, neonatal e infantil,

gestores de unidades de saúde, profissionais de saúde (incluindo parteiras, auxiliares de enfermagem parteiras, enfermeiras, obstetras, pediatras, neonatologistas, médicos de clínica geral e agentes comunitários de saúde), organizações não governamentais, sociedades profissionais envolvidas no planejamento em gestão de serviços de saúde materna, neonatal e infantil, acadêmicos envolvidos no treinamento de profissionais de saúde e grupos de mulheres e pais.

Os termos mulher, mãe, parceria, pais e cuidadores foram usados ao longo desta diretriz. Esses termos foram definidos na tentativa de promover a inclusão de todas as pessoas que deram à luz e em reconhecimento aos diversos papéis de todos os indivíduos envolvidos na prestação de cuidados e apoio durante o período pós-natal.

Métodos de desenvolvimento das diretrizes

As diretrizes foram desenvolvidas usando procedimentos operacionais padrão de acordo com o descrito no *Manual da OMS para desenvolvimento de diretrizes*. Resumidamente, os procedimentos incluem: (i) identificação de questões prioritárias e resultados; (ii) recuperação e síntese de evidências; (iii) avaliação das evidências; (iv) formulação de recomendações; e (v) planejamento para implementação, disseminação, avaliação de impacto e atualização da diretriz. A qualidade das evidências científicas que sustentam as recomendações foi avaliada usando as abordagens de Classificação de Recomendações, Avaliação, Desenvolvimento e Avaliação (GRADE) e Confiança na Evidência de Análises de pesquisas Qualitativas (CERQual) para evidências quantitativas e qualitativas, respectivamente. Os resultados de estudos de custo-benefício individuais foram avaliados usando a lista de verificação Critérios Econômicos de Saúde de Consenso (CHEC). A estrutura DECIDE (Desenvolvimento e Avaliação de Estratégias de Comunicação para Apoiar Decisões Informadas e Práticas Baseadas em Evidências), uma ferramenta de adaptação da evidência para decisão, foi usada para orientar a compilação de evidências, julgamentos sobre os diferentes critérios e a formulação de recomendações pelo Grupo de Desenvolvimento de Diretrizes (GDD), incluindo: os efeitos de uma intervenção nos resultados maternos, neonatais e dos sistemas de saúde, e considerações sobre os valores das mulheres, pais e profissionais de saúde; recursos; equidade; aceitabilidade; e a viabilidade das intervenções. O GDD é um grupo internacional de especialistas reunido com o objetivo de desenvolver esta diretriz – em nove reuniões virtuais do GDD realizadas entre setembro de 2020 e junho de 2021. Além disso, as recomendações existentes das atuais diretrizes da OMS aprovadas pelo Comitê de Revisão de Diretrizes que eram relevantes para o cuidado pós-natal foram identificadas e integradas a esta diretriz com o propósito de fornecer um documento abrangente para os usuários finais.

Recomendações

As reuniões do GDD levaram a 63 recomendações relacionadas ao cuidado pós-natal: 31 são recomendações desenvolvidas recentemente pelo GDD e 32 são recomendações integradas a partir de diretrizes existentes da OMS. As recomendações são agrupadas de acordo com os cuidados maternos, cuidados com os recém-nascidos e sistemas de saúde e intervenções de promoção da saúde (para melhorar a provisão, a utilização e a experiência dos cuidados pós-natais). As intervenções foram classificadas como recomendadas, não recomendadas ou recomendadas sob certas condições com base nos julgamentos do GDD de acordo com os critérios do DECIDE, que definiram a direção e a categoria da recomendação. Onde o GDD recomendou ou não uma intervenção, a recomendação resultante é relevante para todas as mulheres no período pós-parto e recém-nascidos, salvo indicação em contrário na recomendação. Quando o GDD recomendou uma intervenção apenas em contextos específicos, considerou que as evidências eram aplicáveis apenas a essas situações, contextos ou populações. Para todas as recomendações, o GDD fez comentários, incluindo informações contextuais adicionais relacionadas a recomendações específicas ao contexto, quando necessário. Os usuários da diretriz devem consultar essas observações, que são apresentadas junto com os resumos das evidências na versão completa da diretriz.

Implementação

Essas recomendações precisam ser incorporadas dentro de um modelo apropriado de atenção pós-parto e adaptadas às necessidades de diferentes países, contextos locais, mulheres, recém-nascidos, pais, cuidadores e famílias. O GDD propôs considerações de implementação para cada uma das recomendações novas e/ou atualizadas e considerações gerais para a adoção, adaptação e implementação do conjunto de recomendações para garantir atendimento respeitoso, individualizado e centrado na pessoa em cada contato, de acordo com a abordagem baseada nos direitos humanos.

O modelo de atenção pós-natal da OMS coloca o binômio mulher-recém-nascido no centro dos cuidados (Fig. 1). A base deste modelo de atenção pós-parto é um mínimo de quatro contatos de atenção pós-natal. Em particular, o GDD considerou as primeiras duas semanas após o nascimento como um momento chave para promover a saúde, identificar problemas de saúde e apoiar a transição para cuidados com mulheres e bebês

saudáveis. Essa diretriz atual confirma a importância do cuidado pós-natal nas primeiras 24 horas após o nascimento, independente do local de nascimento. Mais especificamente, recomenda-se uma permanência mínima de 24 horas após o nascimento na instituição, com cuidados e acompanhamento contínuo durante essa internação. Critérios expandidos antes da alta foram identificados para avaliar e gerenciar problemas potenciais e para se preparar para a transição para o lar. Ocorrem pelo menos três contatos adicionais de cuidado pós-natal durante as primeiras seis semanas após o nascimento. Isso inclui o fornecimento de práticas clínicas eficazes, informações relevantes e oportunas e apoio psicossocial e emocional, fornecido por profissionais de saúde gentis, competentes e motivados que estão trabalhando dentro de um sistema de saúde em bom funcionamento. Um sistema de referência eficaz, incluindo a comunicação entre prestadores de cuidados de saúde e comunitários, e entre trabalhadores de saúde e do transporte no caso de complicações, também são componentes essenciais deste modelo de cuidado pós-natal.

Monitoramento e avaliação

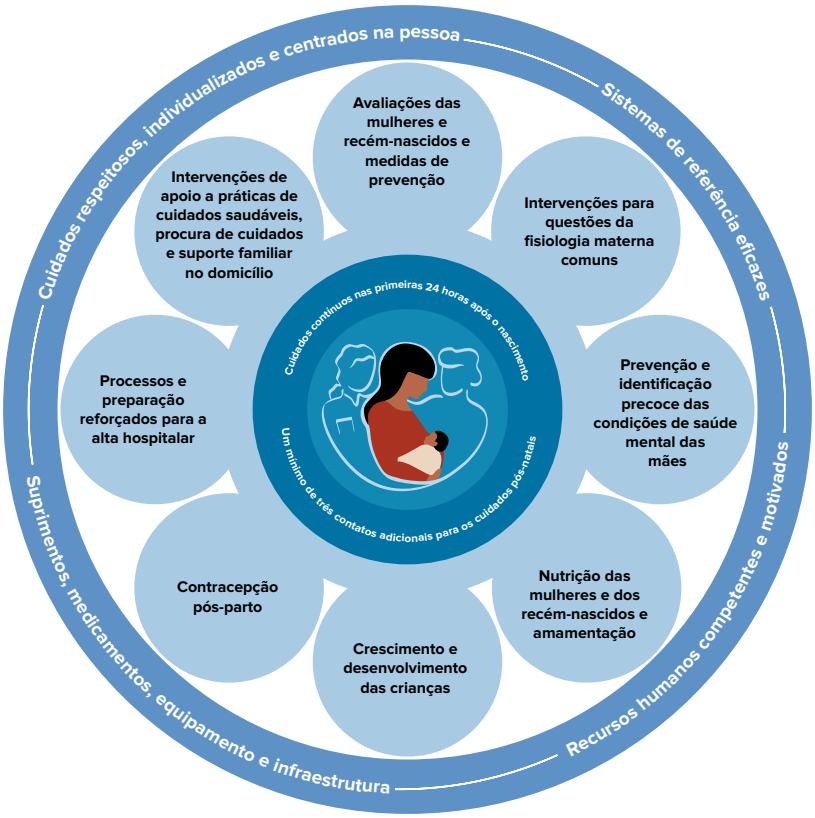
A implementação e o impacto dessas recomendações serão monitorados nos serviços de saúde, nos níveis subnacional e nacional, com base em critérios e indicadores claramente definidos que estão associados às metas acordadas localmente. O GDD sugere os seguintes indicadores a serem considerados, que foram adaptados dos indicadores globais recomendados atuais.[1]

- Tempo de permanência nas unidades de saúde após o nascimento
- Cuidado pós-natal de rotina precoce para mulheres (dentro de dois dias)
- Cuidado pós-natal de rotina precoce para recém-nascidos (dentro de dois dias)
- Vacinação de dose de nascimento contra hepatite B

Atualização das recomendações

De acordo com o processo de atualização das diretrizes da OMS, será empregado um processo sistemático e contínuo de identificação e eliminação das lacunas de evidências após a disseminação das diretrizes. Se novas evidências que podem potencialmente impactar a base de evidências atual para qualquer uma das recomendações forem identificadas, a recomendação será atualizada. A OMS agradece sugestões sobre questões adicionais para inclusão em futuras atualizações das diretrizes.

Figura 1. Representação esquemática do modelo de atenção pós-natal da OMS



1 Portal de dados da OMS sobre saúde e envelhecimento materna, neonatal, infantil, do adolescente, e envelhecimento. Weblink: www.who.int/data/maternal-newborn-child-adolescent-ageing/maternal-and-newborn-data/maternal-and-newborn---coverage.

Resumo das recomendações sobre cuidados maternos e neonatais para uma experiência pós-natal positiva

Categoria de cuidados	Recomendação	Categoria de recomendações
A. CUIDADO MATERNO		
Avaliação materna		
Avaliação fisiológica da mulher[2]	**1.** Todas as puérperas devem ter avaliação regular do sangramento vaginal, tônus uterino, altura uterina, temperatura e frequência cardíaca (pulso) de rotina durante as primeiras 24 horas, começando na primeira hora após o nascimento. A pressão arterial deve ser medida logo após o nascimento. Se normal, a segunda aferição da pressão arterial deve ser feita dentro de 6 horas. A diurese deve ser documentada dentro de 6 horas. Em cada contato pós-parto subsequente além de 24 horas após o nascimento, as investigações devem continuar a ser feitas sobre o bem-estar geral e as avaliações feitas em relação ao seguinte: micção e incontinência urinária, função intestinal, cicatrização de qualquer lesão perineal, dor de cabeça, fadiga, dor nas costas, dor e higiene perineal, dor mamária e sensibilidade uterina e lóquios.	Recomendado
Teste de recuperação de HIV[3]	**2a.** Em cenários com alto índice de HIV,[a] um teste de HIV pós-parto de recuperação é necessário para mulheres HIV-negativas ou status desconhecido que faltaram ao teste de contato pré-natal ou ao reteste no final da gravidez em uma consulta de terceiro trimestre.	Recomendação para contexto específico
	2b. Em cenários com baixo índice de HIV,[b] um o teste de HIV pós-parto de recuperação pode ser considerado para mulheres HIV-negativas ou status desconhecido que faltaram ao teste de contato pré-natal ou ao reteste no final da gravidez em uma consulta de terceiro trimestre como parte do esforço para eliminar a transmissão vertical do HIV. Os países poderiam considerar isso apenas para mulheres em relacionamentos sorodiscordantes, onde parceria não está com supressão viral com TARV, ou que tiveram outros riscos conhecidos de HIV no final da gravidez em uma visita do terceiro trimestre.	Recomendação para contexto específico
Triagem para tuberculose[4]	**3a.** A triagem sistemática para tuberculose pode ser realizada na população geral, incluindo mulheres no período pós-parto, em áreas com uma prevalência estimada de tuberculose de 0,5% ou mais.	Recomendação para contexto específico
	3b. Em locais onde a prevalência da tuberculose na população geral é de 100/100 000 habitantes ou mais, o rastreamento sistemático da tuberculose pode ser realizado entre as mulheres no período pós-parto.	Recomendação para contexto específico
	3c. Contatos domiciliares e outros contatos próximos de indivíduos com tuberculose, incluindo mulheres no período pós-parto e recém-nascidos, devem ser sistematicamente rastreados para tuberculose.	Recomendado
Intervenções para sinais e sintomas fisiológicos comuns		
Resfriamento local para alívio da dor perineal	**4.** O resfriamento local, como bolsas de gelo ou compressas frias, pode ser oferecido às mulheres no período pós-parto imediato para o alívio da dor aguda do trauma perineal sofrido durante o parto, com base nas preferências da mulher e opções disponíveis.	Recomendado

a As configurações de alta prevalência são definidas na publicação da OMS de 2015 *Consolidated guidelines on HIV testing services* como locais com prevalência de HIV superior a 5% na população testada.

b Os locais de baixa prevalência são locais com menos de 5% de prevalência de HIV na população testada.

2 Adaptado e integrado de *WHO recommendations on postnatal care of the mother and newborn* (2014).

3 Adaptado e integrado de *Consolidated guidelines on HIV testing services* (2019)

4 Adaptado e integrado de *WHO consolidated guidelines on tuberculosis. Module 2: screening – systematic screening for tuberculosis disease* (2021).

Categoria de cuidados	Recomendação	Categoria de recomendações
Analgesia oral para alívio da dor perineal	**5.** O paracetamol oral é recomendado como primeira opção quando a analgesia oral é necessária para o alívio da dor perineal pós-parto.	Recomendado
Alívio farmacológico da dor devido a cólica/involução uterina	**6.** Anti-inflamatórios não esteroides orais (AINEs) podem ser usados quando a analgesia é necessária para o alívio da dor pós-parto devido a cólicas uterinas após o parto, com base nas preferências da mulher, na experiência do médico com analgésicos e disponibilidade.	Recomendado
Treinamento dos músculos do assoalho pélvico para fortalecimento do assoalho pélvico	**7.** Para mulheres no pós-parto, não é recomendado iniciar o treinamento muscular do assoalho pélvico de rotina após o parto para a prevenção da incontinência urinária e fecal do pós-parto.	Não recomendado
Intervenções não farmacológicas para tratar ingurgitamento mamária no pós-parto	**8.** Para o tratamento da obstrução mamária no período pós-parto, as mulheres devem ser aconselhadas e apoiadas a praticar a amamentação responsiva, o bom posicionamento do bebê na mama, a expressão do leite materno e o uso de compressas quentes ou frias, com base nas preferências da mulher.	Recomendado
Intervenções farmacológicas para tratar ingurgitamento mamária no pós-parto	**9.** O uso de intervenções farmacológicas como ocitocina subcutânea e terapia com enzimas proteolíticas para o tratamento do ingurgitamento mamário no pós-parto não é recomendado.	Não recomendado
Medidas preventivas		
Intervenções não farmacológicas para prevenir mastite pós-parto	**10.** Para o prevenção da mastite no período pós-parto, as mulheres devem ser aconselhadas e apoiadas a praticar a amamentação responsiva, o bom posicionamento do bebê na mama, a expressão manual do leite materno e o uso de compressas quentes ou frias, com base nas preferências da mulher.	Recomendado
Intervenções farmacológicas para prevenir mastite pós-parto	**11.** A profilaxia antibiótica oral ou tópica de rotina para a prevenção da mastite no período pós-parto não é recomendada.	Não recomendado
Prevenção da constipação pós-parto	**12.** Aconselhamento dietético e informações sobre fatores associados à constipação devem ser oferecidos às mulheres para a prevenção da constipação pós-parto.	Recomendado
	13. O uso rotineiro de laxantes para a prevenção da constipação pós-parto não é recomendado.	Não recomendado
Prevenção de infecção periparto materna após parto vaginal não complicado[5]	**14.** A profilaxia antibiótica de rotina para mulheres com parto vaginal sem complicações não é recomendada.	Não recomendado
Tratamento anti-helmíntico preventivo[6]	**15.** A quimioterapia preventiva (desparasitação), usando albendazol (400 mg) ou mebendazol (500 mg) em dose única anual ou bianual,[c] é recomendada como uma intervenção de saúde pública para todas as meninas adolescentes não grávidas e mulheres em idade reprodutiva, incluindo pós-parto e lactantes, vivendo em áreas onde a prevalência-base de qualquer infecção helmíntica transmitida pelo solo é de 20% ou mais entre meninas adolescentes e mulheres em idade reprodutiva, a fim de reduzir o índice de vermes dos helmintos transmitidos pelo solo.	Recomendação para contexto específico

c A administração semestral é recomendada quando a prevalência da linha de base excede 50%.

5 Integrado de *WHO recommendations for prevention and treatment of maternal peripartum infections* (2015).
6 Adaptado e integrado de *Guideline Preventive chemotherapy to control soil-transmitted helminth infections in at-risk population groups* (2017)

Categoria de cuidados	Recomendação	Categoria de recomendações
Tratamento preventivo de esquistossomose[7]	**16a.** Em comunidades endêmicas com prevalência do *Schistosoma sp* de 10% ou superior, a OMS recomenda quimioterapia preventiva anual com praziquantel em dose única de > 75% a 100% de mulheres grávidas após o primeiro trimestre, e meninas adolescentes não grávidas e mulheres em idade reprodutiva, incluindo pós-parto e lactação mulheres, para controlar a morbidade da esquistossomose e avançar na eliminação da doença como problema de saúde pública.	Recomendação para contexto específico
	16b. Em comunidades endêmicas com prevalência do *Schistosoma sp* de menos de 10%, a OMS sugere uma das duas abordagens com base nos objetivos e recursos do programa: (i) onde houver programa de quimioterapia preventiva regular, continuando a quimioterapia preventiva no mesmo ou com frequência reduzida para interrupção da transmissão; (ii) onde não houver programa de quimioterapia preventiva regular, uma abordagem clínica de teste e tratamento, em vez de quimioterapia preventiva direcionada a uma população.	Recomendação para contexto específico
Profilaxia pré-exposição oral para prevenção do HIV[8]	**17.** A profilaxia pré-exposição (PrEP) oral que contém fumarato de tenofovir desoproxila (TDF) deve ser iniciada ou continuada como uma opção de prevenção adicional para mulheres pós-parto e/ou lactantes com risco substancial de infecção por HIV[d] como parte das abordagens de prevenção de HIV combinadas.	Recomendação para contexto específico
Intervenções de saúde mental		
Triagem para depressão e ansiedade pós-parto	**18.** A triagem para depressão e ansiedade pós-parto com um instrumento validado é recomendada e deve ser acompanhada por serviços de diagnóstico e tratamento para mulheres com triagem positiva.	Recomendado
Prevenção da depressão e ansiedade pós-parto	**19.** Intervenções psicossociais e/ou psicológicas durante o período pré e pós-natal são recomendadas para prevenir a depressão e a ansiedade pós-parto.	Recomendado
Intervenções nutricionais e atividade física		
Suplementação oral de ferro e folato pós-parto[9]	**20.** A suplementação oral de ferro, isoladamente ou em combinação com a suplementação de ácido fólico, pode ser fornecida a mulheres no pós-parto por 6 a 12 semanas após o parto para reduzir o risco de anemia em locais onde a anemia gestacional é um problema de saúde pública.[e]	Recomendação para contexto específico
Suplementação de vitamina A pós-parto[10]	**21.** A suplementação de vitamina A em mulheres no pós-parto para a prevenção da morbidade e mortalidade materna e infantil não é recomendada.	Não recomendado
Atividade física e comportamento sedentário[11]	**22.** Mulheres puérperas sem contra-indicação devem: • realizar atividades físicas regulares durante todo o período pós-parto; • fazer pelo menos 150 minutos de atividade física durante a semana para benefícios substanciais à saúde; e • incorporar uma variedade de atividades físicas e de fortalecimento muscular; adicionar alongamento suave também pode ser benéfico.	Recomendado

d O risco substancial é provisoriamente definido como a incidência de HIV maior do que três por 100 pessoas ao ano na ausência de PrEP.
e A OMS considera uma prevalência de anemia gestacional de 20% ou mais na população um problema de saúde pública moderado.

7 Adaptado e integrado de *WHO guideline on control and elimination of human schistosomiasis* (2022).
8 Adaptado e integrado de *Consolidated guidelines on the use of antiretroviral drugs for treating and preventing HIV infection: Recommendations for a public health approach – Second edition* (2016).
9 Integrado de *Guideline: Iron supplementation in postpartum women* (2016).
10 Integrado de *Diretriz: suplementação de vitamina A em mulheres no pós-parto* (2013).
11 Adaptado e integrado de *WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour* (2020).

Categoria de cuidados	Recomendação	Categoria de recomendações
	23. As mulheres no pós-parto devem limitar o tempo gasto como sedentárias. Substituir o tempo sedentário por atividade física de qualquer intensidade (incluindo intensidade leve) traz benefícios para a saúde.	Recomendado
Contracepção		
Contracepção pós-parto[12]	**24.** Recomenda-se o fornecimento de informações e serviços anticoncepcionais abrangentes durante os cuidados pós-natal.	Recomendado
B. CUIDADOS AOS RECÉM-NASCIDOS		
Avaliação do recém-nascido		
Avaliação do recém-nascido quanto a sinais de perigo[13]	**25.** Os seguintes sinais devem ser avaliados durante cada contato pós-natal, e o recém-nascido deve ser encaminhado para avaliação adicional se algum dos sinais estiver presente: não se alimentando bem; história de convulsões; respiração rápida (frequência respiratória > 60 por minuto); contração torácica severa; nenhum movimento espontâneo; febre (temperatura > 37,5 °C); temperatura corporal baixa (temperatura < 35,5 °C); qualquer icterícia nas primeiras 24 horas após o nascimento ou palmas e solas amarelas em qualquer idade. Incentivamos pais e familiares a procurar cuidados de saúde precocemente se identificarem qualquer um dos sinais de perigo acima entre as consultas de cuidados pós-natais.	Recomendado
Triagem universal para anomalias do olho	**26.** A triagem neonatal universal para anomalias oculares é recomendada e deve ser acompanhada por serviços de diagnóstico e tratamento para crianças identificadas com uma anomalia.	Recomendado
Triagem universal para deficiência auditiva	**27.** A triagem auditiva neonatal universal (UNHS) com emissões otoacústicas (OAE) ou resposta auditiva automática do tronco encefálico (AABR) é recomendada para a identificação precoce da perda auditiva bilateral permanente (PBHL). A UNHS deve ser acompanhada por serviços de diagnóstico e tratamento para crianças identificadas com perda auditiva.	Recomendado
Triagem universal para hiperbilirrubinemia neonatal	**28.** A triagem universal para hiperbilirrubinemia neonatal por bilirrubinômetro transcutâneo (TcB) é recomendada na alta da unidade de saúde.	Recomendado
	29. Não há evidências suficientes para recomendar a favor ou contra a triagem universal por bilirrubina sérica total (TSB) na alta da unidade de saúde.	Nenhuma recomendação emitida
Medidas preventivas		
Horário do primeiro banho para prevenir hipotermia e suas sequelas	**30.** O primeiro banho de um recém-nascido saudável a termo deve ser adiado por pelo menos 24 horas após o nascimento.	Recomendado
Uso de emolientes para a prevenção de doenças da pele	**31.** A aplicação rotineira de emolientes tópicos em recém-nascidos saudáveis para a prevenção de doenças de pele não é recomendada.	Não recomendado
Aplicação de clorexidina no coto do cordão umbilical para prevenção de infecção neonatal	**32a.** Recomenda-se o cuidado do cordão umbilical para que fique limpo e seco.	Recomendado

12 Adaptado e integrado de *Ensuring human rights in the provision of contraceptive information and services: guidance and recommendations* (2013).

13 Adaptado e integrado de *WHO recommendations on postnatal care of the mother and newborn* (2014).

Categoria de cuidados	Recomendação	Categoria de recomendações
	32b. A aplicação diária de clorexidina 4% (solução aquosa de digluconato de clorexidina 7,1% ou gel, fornecendo 4% de clorexidina) no coto do cordão umbilical na primeira semana após o nascimento é recomendada apenas em locais onde substâncias tradicionais nocivas (como esterco animal) são comumente usadas no cordão umbilical.	Recomendação para contexto específico
Posição de dormir para a prevenção da síndrome de morte súbita infantil	**33.** Colocar o bebê para dormir em posição supina durante o primeiro ano após o nascimento é recomendado para prevenir a síndrome de morte súbita infantil (SMSL) e morte súbita inesperada em bebês (SUDI).	Recomendado
Imunização para a prevenção de infecções[14]	**34.** A imunização neonatal deve ser promovida de acordo com as recomendações mais recentes da OMS para imunização de rotina.	Recomendado
Intervenções nutricionais		
Suplementação neonatal de vitamina A	**35a.** A suplementação neonatal de vitamina A de rotina não é recomendada para reduzir a mortalidade neonatal e infantil.	Não recomendado
	35b. Em ambientes com dados recentes (nos últimos cinco anos) e confiáveis que indicam uma alta taxa de mortalidade infantil (mais de 50 por 1000 nascidos vivos)[f] e alta prevalência de deficiência de vitamina A materna (> 10% de mulheres grávidas com concentrações de retinol sérico < 0,70 µmol / L), fornecer aos recém-nascidos uma dose oral única de 50.000 UI de vitamina A nos primeiros 3 dias após o nascimento pode ser considerado para reduzir a mortalidade infantil.	Recomendação para contexto específico
Suplementação de vitamina D para lactantes a termo em amamentação	**36.** A suplementação de vitamina D em lactantes a termo em amamentação é recomendada para melhorar os resultados de saúde infantil apenas no contexto de pesquisas rigorosas.	Recomendação para contexto específico
Crescimento e desenvolvimento de recém-nascidos		
Massagem de corpo inteiro	**37.** A massagem suave de corpo inteiro pode ser considerada para recém-nascidos saudáveis e a termo, por seus possíveis benefícios para o crescimento e desenvolvimento.	Recomendado
Desenvolvimento na primeira infância[15]	**38.** Todos os bebês e crianças devem receber cuidados responsivos entre 0 e 3 anos de idade; os pais e outros cuidadores devem receber apoio para fornecer cuidados responsivos.	Recomendado
	39. Todos os bebês e crianças devem ter atividades de aprendizagem precoce com seus pais e outros cuidadores entre 0 e 3 anos de idade; os pais e outros cuidadores devem ser apoiados para se envolverem na aprendizagem precoce de seus bebês e crianças.	Recomendado
	40. O apoio para cuidados responsivos e aprendizagem precoce deve ser incluído como parte das intervenções para a nutrição ideal de recém-nascidos, bebês e crianças pequenas.	Recomendado
	41. As intervenções psicossociais para apoiar a saúde mental materna devem ser integradas aos serviços de cuidados ao desenvolvimento precoce da criança.	Recomendado

f A taxa de mortalidade infantil proposta de mais de 50 por 1000 nascidos vivos foi calculada com base em várias suposições: 50% da taxa de mortalidade infantil total são mortes neonatais; 50% da mortalidade neonatal ocorre no primeiro dia após o nascimento; a taxa de mortalidade pós-neonatal até 6 meses de idade representa dois terços (2/3) da taxa de mortalidade infantil total, e a taxa de mortalidade entre 6 e 12 meses de idade representa o terço restante (1/3); a taxa de 30 mortes por 1000 usada nos estudos é responsável por mortes entre a inscrição no estudo até os 6 meses de idade; e a dosagem/inclusão quase sempre ocorreu nas primeiras 24 horas após o nascimento.

14 Adaptado e integrado de *WHO recommendations on postnatal care of the mother and newborn* (2014).
15 Adaptado e integrado de *Improving early childhood development: WHO guideline* (2020).

Categoria de cuidados	Recomendação	Categoria de recomendações
Amamentação		
Amamentação exclusiva[16]	**42.** Todos os bebês devem ser amamentados exclusivamente desde o nascimento até os 6 meses de idade. As mães devem ser aconselhadas e receber apoio para amamentação exclusiva em cada contato pós-natal.	Recomendado
Proteger, promover e apoiar a amamentação em instituições que prestam cuidados de maternidade e a recém-nascidos[17]	**43a.** As instalações que oferecem serviços de maternidade e recém-nascidos devem ter uma política de amamentação claramente escrita, que seja rotineiramente comunicada à equipe e aos pais.	Recomendado
	43b. Os funcionários das unidades de saúde que prestam serviços de alimentação infantil, incluindo apoio à amamentação, devem ter conhecimento, competência e habilidades suficientes para dar suporte às mulheres na amamentação.	Recomendado
C. SISTEMAS DE SAÚDE E INTERVENÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE		
Agendamento de contatos de cuidados pós-natal	**44.** Recomenda-se um mínimo de quatro contatos de cuidados pós-natal. Se o parto for em uma unidade de saúde, mulheres e recém-nascidos saudáveis devem receber cuidados pós-natal na unidade por pelo menos 24 horas após o nascimento. Se o parto for em casa, o primeiro contato pós-natal deve ser o mais precoce possível dentro de 24 horas após o nascimento. Recomenda-se pelo menos três contatos pós-natais adicionais para mulheres saudáveis e recém-nascidos, entre 48 e 72 horas, entre sete e 14 dias e durante a sexta semana após o nascimento.	Recomendado
Tempo de permanência nas unidades de saúde após o nascimento	**45.** Recomenda-se cuidar de mulheres e recém-nascidos saudáveis na unidade de saúde por pelo menos 24 horas após o parto vaginal.	Recomendado
Critérios que serão avaliados antes da alta da instituição após o nascimento	**46.** Antes da alta a mulheres e recém-nascidos saudáveis após o parto para casa, os profissionais de saúde devem avaliar os seguintes critérios para melhorar os resultados maternos e neonatais: • o bem-estar físico da mulher e do bebê e o bem-estar emocional da mulher; • as habilidades e a confiança da mulher para cuidar de si mesma e as habilidades e confiança dos pais e cuidadores para cuidar do recém-nascido; e • o ambiente domiciliar e outros fatores que podem influenciar a capacidade de cuidar da mulher e do recém-nascido em casa e seu comportamento de busca por atendimento.	Recomendado
Abordagens para fortalecer a preparação para alta do centro de saúde para casa após o nascimento	**47.** O fornecimento de informações, intervenções educacionais e aconselhamento são recomendados para preparar mulheres, pais e cuidadores para a alta da unidade de saúde após o nascimento para melhorar os resultados de saúde materna e neonatal e para facilitar a transição para o lar. Devem estar disponíveis materiais educativos, como livretos educacionais escritos/digitais, ilustrações para populações semianalfabetas e materiais de apoio.	Recomendado
Visitas domiciliares para contatos pós-natal	**48.** Visitas domiciliares durante a primeira semana após o nascimento por profissionais de saúde qualificados ou um agente de saúde comunitário treinado são recomendadas para o cuidado pós-natal de mulheres e recém-nascidos saudáveis. Quando as visitas domiciliares não são viáveis ou preferenciais, contatos ambulatoriais pós-natal são recomendados.	Recomendado

16 Integrado de *WHO recommendations on postnatal care of the mother and newborn* (2014).
17 Integrado de *WHO guideline Protecting, promoting and supporting breastfeeding in facilities providing maternity and newborn services* (2017).

Categoria de cuidados	Recomendação	Categoria de recomendações
Continuidade de cuidados obstétricos[18]	**49.** Modelos de continuidade de cuidados conduzidos por parteiras, nos quais uma parteira conhecida ou um pequeno grupo de parteiras conhecidas apóia uma mulher durante o período pré-natal, intraparto e pós-natal, são recomendados para mulheres em ambientes com programas de obstetrícia que funcionam bem.	Recomendação para contexto específico
Componentes de compartilhamento de tarefas da prestação de cuidados pós-natal[19]	**50a.** É recomendado o compartilhamento de tarefas para a promoção de comportamentos relacionados à saúde materna e neonatal[g] a uma ampla gama de quadros, incluindo trabalhadores de saúde leigos, auxiliares de enfermagem, enfermeiras, parteiras e médicos.	Recomendado
	50b. Recomenda-se o compartilhamento de tarefas no fornecimento de métodos anticoncepcionais[h] recomendados a uma ampla gama de quadros, incluindo auxiliares de enfermagem, enfermeiras, parteiras e médicos.	Recomendado
Recrutamento e retenção de pessoal em áreas rurais e remotas[20]	**51.** Os responsáveis pelas políticas devem considerar um conjunto de intervenções que abranjam educação e regulamentação, incentivos e apoio pessoal e profissional para melhorar o desenvolvimento, atração, recrutamento e entrega da força de trabalho de saúde em áreas rurais e remotas.	Recomendado
Envolvimento dos homens nos cuidados pós-natal e saúde materna e neonatal[21]	**52.** As intervenções para promover o envolvimento dos homens durante a gravidez, parto e após o nascimento são recomendadas para facilitar e apoiar a melhoria do autocuidado das mulheres, práticas de cuidado domiciliar para mulheres e recém-nascidos e uso de assistência especializada para mulheres e recém-nascidos durante a gravidez, parto e o período pós-natal e para aumentar o uso oportuno de cuidados de saúde para complicações obstétricas e neonatais. Essas intervenções são recomendadas, desde que implementadas de forma que respeite, promova e facilite as escolhas da mulher e sua autonomia na tomada de decisões, e que apoie a mulher no cuidado de si mesma e de seu filho recém-nascido.	Recomendado com monitoramento e avaliação direcionados
Registros domiciliares[22]	**53.** O uso de registros domiciliares, como complemento aos registros hospitalares, é recomendado para o atendimento de mulheres grávidas e puérperas, recém-nascidos e crianças, para melhorar o comportamento de procura de cuidados, o envolvimento e o apoio dos homens no lar, práticas de cuidados maternos e infantis em casa, alimentação de bebês e crianças e comunicação entre profissionais de saúde e mulheres, pais e encarregados de educação.	Recomendado
Comunicação digital direcionada ao cliente[23]	**54.** A OMS recomenda a comunicação digital direcionada ao cliente para mudança de comportamento em relação à saúde sexual, reprodutiva, materna, neonatal e infantil, desde que as preocupações com conteúdo sensível e privacidade de dados sejam tratadas de forma adequada.	Recomendação para contexto específico

g Incluindo a promoção do seguinte: cuidado pós-natal, planejamento familiar (distribuição de preservativos [masculinos e femininos] e outros métodos de contracepção, iniciação e distribuição de anticoncepcionais orais combinados, anticoncepcionais orais só de progestógeno e anticoncepção de emergência e informações e instruções gerais sobre o Standard Days Method, TwoDay Method® e o Lactational Amenorrhea Method), teste e reteste de HIV pós-parto, dormir com mosquiteiros tratados com inseticida, aconselhamento nutricional, suplementos nutricionais, cuidados básicos para recém-nascidos, amamentação exclusiva e imunização de acordo com as diretrizes nacionais.

h Incluindo: iniciar e manter anticoncepcionais injetáveis usando uma seringa padrão com agulha para injeção IM ou subcutânea, inserção de dispositivo intrauterino (DIU), inserção de implantes anticoncepcionais.

18 Integrado de *WHO recommendations on antenatal care for a positive pregnancy experience* (2016).
19 Adaptado e integrado de *WHO recommendations: optimizing health worker roles to improve access to key maternal and newborn health interventions through task shifting* (2012).
20 Adaptado e integrado de *WHO guideline on health workforce development, attraction, recruitment and retention in rural and remote areas* (2021).
21 Retido (após revisão de novas evidências) de *WHO recommendations on health promotion interventions for maternal and newborn health 2015* (2015).
22 Adaptado e integrado de *WHO recommendations on home-based records for maternal, newborn and child health* (2018).
23 Integrado de *WHO guideline: recommendations on digital interventions for health system strengthening* (2019).

Categoria de cuidados	Recomendação	Categoria de recomendações
Notificações digitais de nascimento[24]	**55.** A OMS recomenda o uso de notificações digitais de nascimento nas seguintes condições: • em locais onde as notificações fornecem dados de nível individual para o sistema de saúde e/ou um sistema de registro civil e estatísticas vitais (CRVS); e • o sistema de saúde e/ou sistema CRVS tem capacidade para responder às notificações.	Recomendação para contexto específico

24 Integrado de *WHO guideline: recommendations on digital interventions for health system strengthening* (2019).

World Health Organization

human reproduction programme hrp
research for impact
UNDP · UNFPA · UNICEF · WHO · WORLD BANK

Recomendações da OMS sobre cuidados maternos e neonatais para uma experiência pós-natal positiva: sumário executivo [WHO recommendations on maternal and newborn care for a positive postnatal experience: executive summary]

ISBN 978-92-4-004851-5 (versão electrónica)
ISBN 978-92-4-004852-2 (versão impressa)

© Organização Mundial da Saúde 2022. Alguns direitos reservados. Este trabalho é disponibilizado sob licença CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

Tradução por Ocean Translations. A OMS não é responsável, nem pelo conteúdo, nem pelo rigor desta tradução. Em caso de discrepância entre a versão em inglês e a versão portuguesa, o texto original em inglês será a versão vinculativa e autêntica.

Para mais informações, queira contactar:

Organização Mundial da Saúde
Avenue Appia 20, CH-1211 Geneva 27, Switzerland

Departamento de Saúde Sexual e Reprodutiva e de Investigação
Email: srhmph@who.int
Website: www.who.int/teams/sexual-and-reproductive-health-and-research-(srh)

Departamento de Saúde Materna, Neonatal, da Criança e do Adolescente e o Envelhecimento
Email: mncah@who.int
Website: www.who.int/teams/maternal-newborn-child-adolescent-health-and-ageing/

Departamento de Saúde Mental e de Consumo de Substâncias

Email: mhgap-info@who.int
Website: www.who.int/teams/mental-health-and-substance-use

Departamento de Nutrição e Segurança Alimentar
Email: nutrition@who.int
Website: www.who.int/teams/nutrition-and-food-safety/overview

9789240048515